

Cribado sistémico · Tobillo y pie

PhysiQ-Assessment · fase 2. Preguntas literales de la app. Las listas de banderas rojas y amarillas de cada sistema están en la app.

URGENCIAS · COMPARTIMENTAL Y NEUROVASCULAR · ARTRITIS INFECCIOSA · ROTURA DEL AQUILES · OTTAWA

· SÍNDROME COMPARTIMENTAL Y COMPROMISO NEUROVASCULAR tras lesión grave del mediopié (Lisfranc): el flujo puede caer tras luxarse el 2.º MT → cirugía urgente. Cinco P: palidez · dolor desproporcionado · parestias · sin pulso · frialdad.

· ARTRITIS INFECCIOSA: monoartritis aguda con MALESTAR SISTÉMICO Y FIEBRE ALTA → URGENCIA HOY. En la gota suele estar sistémicamente bien, aunque un brote agudo puede dar fiebre y leucocitosis: solo el análisis del líquido articular las separa.

· ROTURA AGUDA DEL AQUILES: golpe o patada detrás de la pierna en un gesto explosivo, a veces chasquido; camina sorprendentemente bien, con cojera. Thompson: prono, pie fuera de la camilla; al comprimir la pantorrilla el tobillo no se mueve → S 96 % · E 93 % → derivación preferente.

· REGLAS DE OTTAWA, antes de explorar cualquier traumatismo agudo. TOBILLO → radiografía si dolor en la zona maleolar Y alguno: dolor óseo en los 6 cm distales del borde posterior de la tibia o punta del maléolo medial · ídem del peroné o punta del maléolo lateral · no carga cuatro pasos, ni justo tras la lesión ni en consulta. PIE → radiografía si dolor en el mediopié Y alguno: dolor óseo en la base del 5.º MT · en el navicular · no carga cuatro pasos. Muy sensible, moderadamente específica: S 98,5 % en niños de más de 6 años (Lluch, p. 257); en adultos, una regla negativa descarta fractura (LR= 0,08, Bachmann 2003). Excluidas embarazadas y personas que no pueden seguir la prueba (p. ej., traumatismo craneal). ≈10 % de las inversiones acaban en fractura.

Traumático / Mecánico

1. ¿Tras una lesión grave del mediopié, tiene el pie pálido o frío, dormido u hormigueante, sin pulso, o un dolor desproporcionado (cinco P)? **URGENCIA · derivar hoy** rápido
2. ¿Tras el traumatismo no pudo dar cuatro pasos apoyando el pie, ni justo tras la lesión ni ahora en consulta? (Aplicar las reglas de Ottawa en el árbol: radiografía si hay algún criterio.)
3. ¿Notó un golpe o una patada detrás de la pierna en un gesto explosivo, a veces con chasquido, y desde entonces cojea? (Thompson en el árbol: derivación preferente.)
4. ¿Se cayó hacia delante sobre el pie en punta (fallar un escalón) o desde altura sobre el talón, y no puede apoyar? (Lisfranc o calcáneo: derivación preferente.)
5. ¿Se le ha aplanado el arco del pie, o no puede doblar la punta del dedo gordo, tras un impulso, un aterrizaje forzado o una tendinopatía que va a más (rotura del tibial posterior o del FHL)?

Fractura de Estrés

1. ¿El dolor apareció poco a poco tras un cambio de carga (más entrenamiento, otro calzado, otra superficie), no mejora al calentar y le molesta por la noche?
2. ¿Ha tenido más de dos fracturas de estrés en huesos distintos? (Derivar: densidad ósea, RED-S, endocrino, nutricional.)

Infecciosa / Inflamatoria

1. ¿Tiene una articulación del tobillo o del pie hinchada y muy dolorosa, con fiebre alta y malestar general? **URGENCIA · derivar hoy** rápido
2. ¿Tiene rigidez por la mañana de más de 60 minutos que mejora al moverse, o hinchazón caliente en varias articulaciones, algún dedo hinchado entero o cambios en las uñas?

Oncológico / Sistémico

1. ¿Tiene fiebre, sudores nocturnos o ha perdido peso sin explicación, o el dolor le despierta por la noche?
2. (Niño o joven) ¿Tiene un dolor sordo que empeora por la noche, sin relación con la actividad, y que se le alivia en menos de 20 minutos con un antiinflamatorio? (Osteoma osteoide: derivar.)

Vascular

1. ¿Le aparece dolor o calambre siempre tras la misma distancia o el mismo tiempo de esfuerzo?
2. ¿Tras una inmovilización, una férula, estar encamado o una cirugía reciente, tiene la pantorrilla o toda la pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.) **URGENCIA · derivar hoy**

Neurológico

1. ¿Tiene debilidad en las dos piernas que va a más en días o pocas semanas? (Explorar reflejos: con arreflexia, derivación el mismo día.) **URGENCIA · derivar hoy** rápido
2. ¿Tiene ardor, hormigueo o pérdida de sensibilidad en los dos pies (p. ej., con diabetes), o se le cae el pie al caminar?
3. Desde una lesión, ¿tiene el pie enrojecido, con cambios de temperatura o sudoración, hinchado más allá de la fase aguda, o le duele al mínimo roce?

Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. ¿Ha notado heces negras/alquitrinadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo las preguntas de URGENCIA): evaluar en el contexto clínico completo. «rápido» = pregunta del screening rápido. Generado desde los datos de la app el 6/10/2026.